

DOTYCZY DZIECKA _____

GRUPA / KLASA _____

DATA _____

r.

OPINIA PRZEDSZKOLA / SZKOŁY · DLA ZESPOŁU ORZEKAJĄCEGO · DLA RODZICA

OCENA FUNKCJONALNA · ICF · PRZEDSZKOLE · SZKOŁA

Raport Oceny Funkcjonalnej

OBSERWACJA WSTĘPNA I POGŁĘBIONA · OBSZARY ICF

z dnia _____

OPRACOWANY PRZEZ ZESPÓŁ W SKŁADZIE

- | | |
|----------|----------|
| 1. _____ | 2. _____ |
| 3. _____ | 4. _____ |
| 5. _____ | 6. _____ |

§

PODSTAWA PRAWNA

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji z dnia 2 marca 2026 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (**Dz. U. z 2026 r. poz. 428**), a w szczególności wchodzącymi w życie z dniem 1 września 2026 r. przepisami **§ 7 ust. 6 i ust. 7**, opinia przedszkola/szkoły wydawana dla zespołu poradni (i przekazywana rodzicowi) musi mieć ściśle określoną strukturę opartą na obszarach ICF: odrębnych dla dziecka w wieku przedszkolnym oraz dla ucznia szkoły.

■ CZĘŚĆ I · PODSTAWA, METRYCZKA I NARZĘDZIA

1

Metryczka bazowa

dane dziecka, wariant wsparcia, podstawa formalna, zdrowie i farmakoterapia

2

Obserwacja wstępna

procedura wrzeźniowej obserwacji
Kwestionariuszem Oceny Funkcjonalnej w obszarach ICF

3

Obserwacja pogłębiona

wskazania i narzędzia: ABC, Profil Biopsychospołeczny, Profil Sensoryczny, mowa i AAC, ToM

■ CZĘŚĆ II · WYNIKI ILOŚCIOWE I JAKOŚCIOWE, OCENA POGŁĘBIONA, KIERUNKI WSPARCIA W IPE

4

Funkcjonowanie w placówce

mocne strony, uzdolnienia i trudności

5

Wyniki liczbowe

KPOF / KSzOF w 9 domenach ICF

6

Analiza jakościowa

opis barier i zalecenia do IPE

7

Obserwacja pogłębiona

wyniki arkuszy specjalistycznych

8

Podjęte działania

zakres wsparcia i efektywność

ICF

KSzOF

ABC

Profil Sensoryczny

AAC

ToM

DOTYCZY DZIECKA _____

GRUPA / KLASA _____

DATA _____ r.

1 METRYCZKA BAZOWA

IMIĘ I NAZWISKO	[Imię i Nazwisko dziecka / ucznia]
DATA URODZENIA	[Data urodzenia]
PLACÓWKA / ODDZIAŁ	[Nazwa przedszkola / szkoły, grupa / klasa]
WARIANT WSPARCIA	☐ Wariant A – wsparcie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ☐ Wariant B – wsparcie w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej (bez orzeczenia)
JEDNOSTKA / PODSTAWA FORMALNA	Na podstawie dołączonego dokumentu: [Orzeczenie / Opinia] nr [Numer] z dnia [Data], wydanego przez: [Nazwa Poradni], z uwagi na: [np. autyzm, w tym zespół Aspergera / niepełnosprawność ruchowa / inne]
SCHOROZENIA PRZEWLEKŁE	☐ Brak ☐ Występują: [np. cukrzyca, astma, epilepsja]
FARMAKOTERAPIA I WSKAZANIA LEKARZA	Zgodnie ze wskazaniami lekarza dziecko/uczeń stale / doraźnie przyjmuje leki: [Nazwa leków, zalecenia postępowania / Nie dotyczy]

2 PODSTAWA I PROCEDURA OBSERWACJI WSTĘPNEJ

1 Zgłoszenie zgłaszane trudności w funkcjonowaniu oraz wniosek rodzica	2 Dokumentacja posiadana opinia / orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej	3 Obserwacja · wrzesień Kwestionariusz Przedszkolnej / Szkolnej Oceny Funkcjonalnej	4 Analiza ICF obszary zgodne z Międzynarodową Klasyfikacją Funkcjonowania
--	---	---	---

Z uwagi na zgłaszane trudności w funkcjonowaniu, wniosek rodzica oraz posiadaną dokumentację (w tym opinię/orzeczenie poradni), w placówce przeprowadzono **we wrześniu** obserwację poziomu funkcjonowania z wykorzystaniem **Kwestionariusza Przedszkolnej / Szkolnej Oceny Funkcjonalnej**, analizującego funkcjonowanie w obszarach zgodnych z Międzynarodową Klasyfikacją Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF).

Funkcje ciała
bStruktury ciała
sAktywność i
uczestnictwo
dCzynniki środowiskowe
eCzynniki osobowe
—

DOTYCZY DZIECKA _____

GRUPA / KLASA _____

DATA _____

r.

3 WSKAZANIA DO OBSERWACJI POGŁĘBIONEJ I ZASTOSOWANE NARZĘDZIA

W związku ze zidentyfikowanymi w toku oceny wstępnej trudnościami w funkcjonowaniu – w szczególności w zakresie **trudnych zachowań, rozwoju funkcji poznawczych, przetwarzania bodźców** oraz **komunikacji** – przeprowadzono obserwację pogłębioną z wykorzystaniem następujących narzędzi specjalistycznych:

ZACHOWANIA TRUDNE

Arkusze Obserwacji Behawioralnej ABC

Zastosowany z uwagi na występowanie zachowań trudnych – identyfikacja bodźców wywołujących, formy zachowania oraz funkcji i skutków podtrzymujących.

A

bodźce wywołujące

B

forma zachowania

C

funkcja i skutki podtrzymujące

CAŁOŚCIOWY OBRAZ

Profil Biopsychospołeczny

Ujęcie funkcjonowania dziecka w wymiarze biologicznym, psychologicznym i społecznym – zgodnie z modelem ICF.

PRZETWARZANIE BODŹCÓW

Profil Sensoryczny

Ocena reaktywności sensorycznej (nadwrażliwości, podwrażliwości, poszukiwania stymulacji) i wpływu bodźców środowiskowych na dysregulację dziecka.

KOMUNIKACJA

Arkusze Oceny Rozwoju Mowy i Komunikacji

Zastosowany w związku ze specyficznymi trudnościami w nadawaniu i rozumieniu mowy, echolaliami lub potrzebą wdrożenia / rozwijania AAC.

FUNKCJE POZNAWCZE I SPOŁECZNE

Arkusze Poziomu Rozwoju Teorii Umysłu (ToM)

Zbadanie poziomu rozumienia stanów mentalnych, intencji, perspektywy i emocji innych osób w sytuacjach społecznych.

DOTYCZY DZIECKA _____

GRUPA / KLASA _____

DATA _____

r.

RAPORT OCENY FUNKCJONALNEJ DZIECKA / UCZNIA · CZĘŚĆ II

Wyniki ilościowe i jakościowe, ocena pogłębiona oraz kierunki wsparcia w IPE

WYNIKI POSZCZEGÓLNYCH ARKUSZY OBSERWACJI · § 7 UST. 6

4 INFORMACJA O FUNKCJONOWANIU W PLACÓWCE – TRUDNOŚCI, MOCNE STRONY I UZDOLNIENIA

§ 7 ust. 6 pkt 3. Syntetyczne zestawienie potencjału rozwojowego oraz barier zidentyfikowanych w toku codziennej aktywności przez nauczycieli, wychowawców i specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem/ucznem:

OBSZAR OBSERWACJI	✓ MOCNE STRONY, ZASOBY I UZDOLNIENIA	► TRUDNOŚCI, OGRANICZENIA I BARIERY
Aktywność poznawcza i uczenie się	Bardzo dobra pamięć wzrokowa; szybkie zapamiętywanie schematów graficznych; wąskie, ale głębokie zainteresowania tematyczne; wysoka motywacja do pracy z ulubionymi pomocami dydaktycznymi.	Trudności z przerzutnością i podzielnością uwagi; szybka męczliwość przy instrukcjach wieloetapowych; problem z uogólnianiem (generalizacją) wiedzy; wymagane stałe tempo i pomoce wizualne.
Komunikacja i porozumiewanie się	Prawidłowe rozumienie prostych, jednoznacznych komunikatów słownych wspartych gestem; sygnalizowanie podstawowych potrzeb fizjologicznych.	Dosłowne rozumienie wypowiedzi (trudność z metaforą i żartem); echolalie odroczone; trudności w inicjowaniu dialogu i naprzemienności wypowiedzi w grupie rówieśniczej; potrzeba wsparcia AAC.
Relacje społeczne i emocje	Chęć przebywania w pobliżu grupy; pozytywna reakcja na stałych, przewidywalnych dorosłych; przestrzeganie czytelnych zasad wizualnych.	Trudności w odczytywaniu emocji i intencji innych (słaba teoria umysłu); niska tolerancja frustracji w sytuacjach przegranej lub nagłej zmiany; tendencja do wycofywania się lub zachowań trudnych.
Motoryka i sprawność fizyczna	Sprawność w zakresie motoryki dużej (bieganie, wspinanie się); chętnie uczestnictwo w zabawach ruchowych w otwartej przestrzeni.	Obniżona precyzja motoryki małej i koordynacji wzrokowo-ruchowej; nieprawidłowy chwyt pisarski / narzędzi; wzmożone lub obniżone napięcie posturalne; męczliwość ręki wiodącej.
Samoobsługa i autonomia	Samodzielność w zakresie podstawowych nawyków higienicznych i toaletowych; znajomość własnej szafki i osobistych przyborów.	Opór sensoryczny przy myciu rąk (wrażliwość na fakturę mydła/wodę); wybiórczość pokarmowa; problem z ubieraniem odzieży wierzchniej ze skomplikowanymi zapinkami; potrzeba nadzoru dorosłego.

DOTYCZY DZIECKA _____

GRUPA / KLASA _____

DATA _____

r.

5

AKTUALNA WIELOSPECJALISTYCZNA OCENA POZIOMU FUNKCJONOWANIA – WYNIKI LICZBOWE

§ 7 ust. 6 pkt 4. Zestawienie parametrów ilościowych uzyskanych z narzędzia bazowego (KPOF dla przedszkola / KSzOF dla szkoły) w 9 obszarach Międzynarodowej Klasyfikacji ICF:

NARZĘDZIE BAZOWE

KPOF / KSzOF

PUNKTY SUROWE

68 / 180 pkt

ŚREDNIA / STEN

Śr: 2,1 · Sten 4

OGÓLNY POZIOM WSPARCIA

Poziom 2

(Umiarkowany)

KOD	DOMENA ICF	PUNKTY / ŚR.	STEN	POZIOM WSPARCIA	WSKAŹNIK FUNKCJONALNY
d1	Uczenie się i stosowanie wiedzy	Śr: 2,4 (12 pkt)	Sten 4	Poziom 2 · Średni	Wymaga podziału zadań na etapy i wsparcia wizualnego.
d2	Ogólne zadania i wymagania	Śr: 1,8 (9 pkt)	Sten 3	Poziom 3 · Wysoki	Brak elastyczności, silny stres przy nagłych zmianach.
d3	Komunikacja i porozumiewanie się	Śr: 2,0 (10 pkt)	Sten 4	Poziom 2 · Średni	Echolalie, konieczność wdrażania schematów AAC.
d4	Poruszanie się i motoryka	Śr: 3,2 (16 pkt)	Sten 6	Poziom 1 · Niski	Ogólna motoryka dobra; obniżona grafomotoryka.
d5	Dbanie o siebie i samoobsługa	Śr: 2,2 (11 pkt)	Sten 4	Poziom 2 · Średni	Wybiórczość sensoryczna przy posiłkach i toalecie.
d6	Życie domowe / Obowiązki placówki	Śr: 2,8 (14 pkt)	Sten 5	Poziom 1 · Niski	Sprząta kąpek zabaw po bezpośrednim przypomnieniu.
d7	Relacje i kontakty międzyludzkie	Śr: 1,6 (8 pkt)	Sten 3	Poziom 3 · Wysoki	Bariery w interakcjach rówieśniczych, konflikty, wycofanie.
d8	Główne dziedziny życia (Edukacja)	Śr: 2,0 (10 pkt)	Sten 4	Poziom 2 · Średni	Wymaga dostosowania metod i stałego nadzoru nauczyciela.
d9	Życie społecznościowe i obywatelskie	Śr: 1,8 (9 pkt)	Sten 3	Poziom 3 · Wysoki	Trudność w uczestnictwie w apelach i wyjściach zbiorowych.

Pasek: średnia w skali 0–5

Poziom 1 · Niski

Poziom 2 · Średni

Poziom 3 · Wysoki

DOTYCZY DZIECKA _____

GRUPA / KLASA _____

DATA _____

r.

6 ANALIZA JAKOŚCIOWA OBSZARÓW OBSERWACJI ORAZ ZALECENIA DO IPE

Szczegółowa diagnoza funkcjonalna powiązana bezpośrednio ze sformułowanymi rekomendacjami do **Indywidualnego Programu Edukacyjnego (IPE)**:

DOMENA ICF	OPIS FUNKCJONOWANIA I BARIERY	ZALECENIA DO IPE (METODY / DOSTOSOWANIA)
Uczenie się i stosowanie wiedzy d1, d2	Dziecko/uczeń przyswaja wiedzę głównie kanałem wzrokowym. Występuje trudność w samodzielnej organizacji pracy, rozumieniu poleceń złożonych oraz transferze wiedzy. Przebodźcowanie powoduje dekoncentrację i rezygnację z zadania.	• Wprowadzenie planów aktywności w formie piktogramów / checklist. • Dzielenie instrukcji na pojedyncze, sekwencyjne kroki. • Stosowanie pomocy sensorycznych (stoper, zegar time-timer). • Wydłużenie czasu na realizację zadań pisemnych i wykonawczych.
Komunikacja i porozumiewanie się d3	Wypowiedzi cechują się trudnościami pragmatycznymi, obecnością echolalii oraz dosłownością interpretacji. W chwilach przeciążenia emocjonalnego następuje mutyzm wybiórczy lub krzyk zamiast komunikacji intencjonalnej.	• Wdrożenie tablic wyboru i skryptów dialogowych AAC. • Unikanie metafor, sarkazmu, dwuznaczności w komunikatach personelu. • Trening komunikacji funkcjonalnej (FCT – sygnalizowanie: „chcę przerwę”, „nie rozumiem”). • Indywidualna terapia logopedyczna/neurologopedyczna (2x w tyg.).
Relacje i interakcje międzyludzkie d7, d9	Trudności w inicjowaniu i podtrzymywaniu zabawy naprzemiennej. Brak umiejętności rozpoznawania sygnałów niewerbalnych wysyłanych przez rówieśników. Częste nieporozumienia prowadzące do zachowań oporowych.	• Udział w Treningu Umiejętności Społecznych (TUS) w małej grupie. • Modelowanie zachowań prospołecznych z wykorzystaniem Historyjek Społecznych (Social Stories). • Asystowanie w zabawach grupowych na zasadzie rówieśnika-mentora. • Jasne, wizualne zasady panujące w klasie/grupie.
Dbanie o siebie i motoryka d4, d5, d6	Samoobsługa zaburzona przez silne reakcje nadwrażliwości na bodźce dotykowe (ubrania, mokre ręce) i zapachowe. Spowolniona koordynacja ruchowa i trudności z planowaniem motorycznym (dyspraksja).	• Dostosowanie przyborów (nakładki ergonomiczne na ołówki, nożyczki sprężynowe). • Stała kolejność czynności toaletowych wsparta paskiem wizualnym. • Indywidualne ćwiczenia rewalidacyjne ukierunkowane na motorykę małą i dużą.

DOTYCZY DZIECKA _____

GRUPA / KLASA _____

DATA _____

r.

7 WYNIKI OBSERWACJI POGŁĘBIONEJ (NARZĘDZIA SPECJALISTYCZNE)

Arkusz Obserwacji Behawioralnej ABC

Zidentyfikowano **14 epizodów** zachowań trudnych. **Bodźce wyzwajające (A)**: trudne polecenia pisemne, hałas, niespodziewane przejścia między aktywnościami. **Topografia zachowania (B)**: głośny krzyk, odmowa zejścia z dywanu, odpychanie kart pracy. **Funkcja (C)**: ucieczka przed przeciążeniem sensorycznym / zadaniem trudnym poznawczo.

Zalecenie: protokół wyprzedzający i nauka komunikatu zastępczego.

Profil Sensoryczny (Kwestionariusz Przetwarzania)

Reaktywność mieszana. **Układ słuchowy** – silna nadwrażliwość na nagłe dźwięki i gwar korytarza (zalecane słuchawki); **układ dotykowy** – obronność dotykowa na faktury klejące i mokre; **układ proprioceptywny i przedsionkowy** – poszukiwanie stymulacji dociskowej i ruchowej (huśtanie, kołysanie się).

Profil Biopsychospołeczny

Uwarunkowania biologiczne: spektrum autyzmu, zaburzenia snu wpływają na zmęczenie poranne. **Uwarunkowania psychologiczne**: silny lęk przed zmianą schematu, sztywność poznawcza. **Czynniki środowiskowe**: wysokie zaangażowanie rodziny, pozytywna reakcja na stałą kadrę.

Arkusz Oceny Rozwoju Mowy i Komunikacji

Zasób słownika biernego w normie wiekowej; wąski zasób czynny w sytuacjach swobodnych. Występują **echolalie natychmiastowe** i trudności pragmatyczne (brak intonacji, trudność w podtrzymaniu dialogu).

Zalecenie: schematy dialogowe i piktogramy wspierające.

Arkusz Poziomu Rozwoju Teorii Umysłu (ToM)

Poziom rozwoju ToM **poniżej normy wiekowej**. Trudność w zadaniach z fałszywym przekonaniem (False Belief Task) oraz w rozpoznawaniu perspektywy i intencji innych osób. Trudności te generują konflikty rówieśnicze przez błędną interpretację zachowań kolegów.

DOTYCZY DZIECKA _____

GRUPA / KLASA _____

DATA _____ r.

8 INFORMACJA O DZIAŁANIACH PODJĘTYCH W CELU POPRAWY FUNKCJONOWANIA

§ 7 ust. 6 pkt 6.

RODZAJ WSPARCIA	ZAKRES WDROŻONYCH DZIAŁAŃ I METODY	EFEKTYWNOŚĆ I OBSERWOWANE ZMIANY
Dostosowania środowiskowe i dydaktyczne	Wyznaczenie strefy wyciszenia w sali; zredukowanie bodźców wzrokowych na tablicach ściennych; zastosowanie słuchawek wygłuszających podczas pracy stolikowej; wprowadzenie indywidualnego planu dnia na rzepy.	Spadek liczby epizodów trudnych zachowań o ok. 40%; wydłużenie czasu skupienia na pojedynczym zadaniu z 3 do 8 minut.
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna i rewalidacja	Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne (TUS – 1x w tyg.); indywidualne zajęcia logopedyczne (1x w tyg.); ćwiczenia integracji sensorycznej (SI) na sali gimnastycznej.	Lepsze tolerowanie obecności innych dzieci w trakcie zajęć kierowanych; pierwsze próby proszenia o przerwę za pomocą gestu/piktogramu.
Współpraca z domem rodzinnym	Cotygodniowe konsultacje z rodzicami; zeszyt korespondencji dom-placówka; ujednolicenie systemu komunikatów i nagród behawioralnych.	Wysoka spójność w reakcjach dorosłych na zachowania trudne; wzrost poczucia bezpieczeństwa u dziecka.

Informacja dla rodzica. Niniejszy raport stanowi opinię placówki o funkcjonowaniu dziecka i jest przekazywany rodzicowi oraz zespołowi orzekającemu poradni. Wyniki obserwacji służą zaplanowaniu wsparcia, a nie ocenie dziecka. Zachęcamy do rozmowy z Zespołem o każdej części dokumentu.

Koordinator Zespołu

podpis i data

Dyrektor placówki

podpis i data

Specjalista

podpis i data

Rodzic / opiekun prawny – zapoznałam/em się z raportem

podpis i data